

Передозування наркотичними речовинами

Сценарій

Ви лікар з медицини невідкладних станів. В складі бригади екстреної медичної допомоги ви прибуваєте на виклик до чоловіка 45 років, який лежав на зупинці, поряд з ним шприц з голкою

Скарги: не формує

Анамнез хвороби:Зі слів перехожих знепритомнів близько 10 хв назад. Після чого було викликано бригаду ЕНМ.

Об'єктивно:без свідомості, шкірні покриви блідо-ціанотичні АТ 90/50 мм.рт.ст. PS60уд. за хв. Під час проведення огляду слідиблювання.

Необхідно: провести диференційну діагностику, встановити діагноз, визначити тактику надання невідкладної допомоги, надати невідкладну допомогу.

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнтом(родичами, свідками) встановлення контакту. Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	<i>Сказати Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я). Ви даєте свою згоду на проведення обстеження та медичних маніпуляцій (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.2	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Анамнез хвороби	<i>Сказати «Що з Вами трапилось» Очікуваний відповідь «Не відповідає. Зі слів перехожих знепритомнів близько 10 хв назад. Після чого було викликано бригаду ЕНМ</i>
2.2	Скарги постраждалого	<i>Сказати:Не відповідає</i>
2.3	Анамнез життя	<i>Сказати: «Які захворювання ви перенесли?» Очікувана відповідь:не відповідає</i>

2.4	Алергійний анамнез	Сказати «Чи були у Вас алергійні прояви раніше і на що?»
		Очікувана відповідь: не відповідає
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати:тяжкий за рахунок церебральної та серцево-судинної недостатності
3.2	Прогресування хвороби	Сказати:«Під час проведення огляду без покращення стану
4.Діагностика		
4.1	Встановити клінічний діагноз	Сказати :Передозування опіоїдами
5.Визначення тактики ведення та лікування. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги		
5.1	Перший крок: Рекомендується перша лінія лікування з нолаксоном в/в	Сказати : «Беру шприц та вводжу розчин нолаксону в дозі 0.4-2.0мг внутрішньовенно назвати час введення дози» Сказати: «Ін'єкцію налоксону можна повторити через 50–90 хв
5.2	Другий крок: з урахуванням нестабільності кровообігу необхідно надати положення лежачі на спині з піднятими нижніми кінцівками. Третій крок: Всім пацієнтам для покращення оксигенаціїслід вводити високу концентрацію кисню через маску до 6-8 літрів за хвилину. Маска повинна бути відповідного розміру. Її слід правильно та щільно надіти на обличчя пацієнта.	Виконати: «Перекласти подушку під ноги чи перевести нижній кінець ліжка у підвищене положення» Сказати: «Щільно надягаю кисневу маску відповідного розміру на обличчя постраждалого та подаю потік 100% кисню 6–8 л/хв.»
5.3	Четвертий крок: Внутрішньовенні рідини повинні бути введені пацієнтам із серцево-судинною нестабільністю. Рідини, які слід обирати в даному випадку, це електроліти, і вони повинні бути введені у болюсах 20 мл/кг (5-10 мл/кг в перші 5-10 хвилин дорослому.	Сказати: «Забезпечую венозний доступ, розпочинаю інфузію 0,9% розчину натрію хлориду в дозі 10 мл/кг. При необхідності швидкого введення розчину, я стискаю флакон»

5.4	П'ятий крок: Після проведення першочергового і другочергового лікування для попередження блюваннята аспірації використовують антагоніст сератонінових 5 НТ 3-рецепторів. Ондасетрон, 8-16 мг а також центральний антагоніст допамінових рецепторів. Метаклопрамід 10мг Шостий крок: Пацієнти з передозуванням опіоїдів потребують постійного моніторингу вітальних функцій та переведення до відділення інтенсивної терапії. При наростанні дихальної та церебральної недостатності хворому необхідна інтубація трахеї та переведення на ШВЛ	<i>Сказати:</i> «Беру шприц та вводжу внутрішньовенно гідрокортизон 2 мг/кг. <i>Сказати:</i> «Беру шприц та вводжу метаклопрамід в дозі 10 мг внутрішньовенно» або ондасетрон 8мг внутрішньовенно <i>Сказати:</i> «Постраждалий бригадою екстреної невідкладної допомоги доставляється до профільного закладу для подальшого нагляду та лікування».
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	<i>Сказати :-</i> Спокійний режим, уникнення вживання наркотичних речовин, виконання рекомендацій лікарів в подальшому обстежені та лікуванні.. Постановка на облік до наркологічного диспансеру.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Сказати-</i> Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при дії наркотичних речовин на Ваш організм, і в подальшому при виникненні таких ситуацій можливі летальні наслідки.